



Doenças Orais e Nutrição em Gastroenterologia

Parte 3 — Módulo Avançado de Especialização | Páginas 121–180

Esta seção aprofunda as manifestações orais de doenças sistêmicas, as infecções da cavidade oral no contexto da gastroenterologia, e a interface crítica entre estado nutricional, imunologia e saúde bucal. O domínio deste conteúdo é essencial para o gastroenterologista que busca uma abordagem clínica integrada e de excelência.

Estrutura do Módulo

O Que Você Vai Aprender

01

Infecções Orais

Candidíase, infecções virais (HSV, EBV, HPV) e bacterianas — fisiopatologia, formas clínicas, diagnóstico e tratamento.

03

Doenças Gastroenterológicas

Manifestações orais da doença celíaca, doença de Crohn, retocolite ulcerativa e uso de imunobiológicos.

02

Nutrição e Mucosa Oral

Deficiências específicas de ferro, vitaminas B12, ácido fólico, zinco e desnutrição proteico-calórica e suas repercussões orais.

04

Raciocínio Clínico e Casos

Fluxo de atendimento, armadilhas diagnósticas, casos clínicos avançados e integração multidisciplinar.

Infecções Orais — Visão Geral

As infecções da cavidade oral representam manifestações frequentes e, muitas vezes, subestimadas em pacientes com alterações imunológicas, nutricionais ou sistêmicas. Para o gastroenterologista, seu reconhecimento precoce pode ser decisivo no diagnóstico e manejo de condições subjacentes graves.

Fúngicas

Predomina a *Candida albicans*. Principal causa de infecção oportunista oral. Reflete desequilíbrio imunológico ou da microbiota.

Virais

Herpes simples (HSV-1), Epstein-Barr (EBV) e HPV são os principais agentes. Frequentemente associados à imunossupressão.

Bacterianas

Menos comuns como infecções primárias, mas relevantes em pacientes imunossuprimidos e em contextos de infecções odontogênicas complicadas.

📌 A avaliação das infecções orais deve sempre considerar o contexto clínico global do paciente — a lesão oral pode ser a primeira manifestação visível de uma doença sistêmica grave.

Candidíase Oral — Introdução e Contexto

A candidíase oral é a **infecção fúngica mais comum da cavidade oral**, causada predominantemente pela *Candida albicans*. Trata-se de uma infecção oportunista, ou seja, ocorre quando os mecanismos de defesa do hospedeiro estão comprometidos — seja por imunossupressão, alteração da microbiota ou comprometimento da barreira mucosa.

Na prática gastroenterológica, a candidíase oral é encontrada com frequência em pacientes:

- Em uso prolongado de antibióticos de amplo espectro
- Com imunossupressão por corticoides ou imunobiológicos
- Portadores de xerostomia por múltiplas causas
- Com desnutrição proteico-calórica significativa
- Com doenças inflamatórias intestinais em atividade

O reconhecimento precoce é fundamental, pois a candidíase oral recorrente ou refratária pode ser o sinal de alerta para doenças sistêmicas ainda não diagnosticadas.

Por que o Gastroenterologista deve conhecer?

Muitos dos pacientes em acompanhamento gastroenterológico são cronicamente imunossuprimidos ou apresentam deficiências nutricionais que predispõem à candidíase. A identificação da lesão oral durante a consulta pode antecipar o diagnóstico e evitar complicações como a candidíase esofágica.

Fisiopatologia da Candidíase Oral

Candida albicans é um comensal da cavidade oral presente em até 50–65% dos indivíduos saudáveis, sem causar doença. A transição de comensal para patógeno — chamada de **virulência oportunista** — depende do desequilíbrio entre três eixos fundamentais:



Flora Oral

O uso de antibióticos de amplo espectro elimina bactérias comensais protetoras, criando um nicho ecológico favorável para a proliferação fúngica. A ausência de competição bacteriana é um dos principais gatilhos para a candidíase iatrogênica.



Sistema Imunológico

A imunidade celular (linfócitos T CD4+) e a imunidade inata (neutrófilos, macrófagos) são as principais defesas contra *Candida*. Qualquer condição que comprometa esses mecanismos — HIV, corticoterapia, quimioterapia — aumenta drasticamente o risco.



Integridade da Mucosa

A mucosa oral íntegra funciona como barreira física e imunológica. Xerostomia, quimioterapia, radioterapia cervical e desnutrição comprometem essa barreira, facilitando a adesão e invasão fúngica pelos filamentos de hifa da *Candida*.

Fatores Predisponentes à Candidíase Oral

Condições Sistêmicas

→ Diabetes Mellitus

Hiperglicemia favorece o crescimento fúngico e reduz a função de neutrófilos. Candidíase recorrente pode ser a primeira manifestação de DM não diagnosticado.

→ HIV / AIDS

A candidíase oral é marcador de progressão da doença e queda de CD4+. Presente em até 90% dos pacientes com AIDS sem tratamento.

→ Desnutrição

Compromete a imunidade celular e a integridade da mucosa, criando ambiente propício à infecção fúngica.

→ Idade Avançada

Imunossenescência, xerostomia fisiológica e uso de múltiplos medicamentos aumentam a vulnerabilidade.

Fatores Iatrogênicos

→ Uso de Corticoides

Tanto sistêmicos quanto inalatórios (especialmente sem higiene bucal após uso). Reduzem imunidade local e alteram microbiota oral.

→ Quimioterapia

Provoca mucosite, xerostomia e neutropenia — tripla combinação de risco para candidíase oral grave.

→ Antibioticoterapia

Amplo espectro destrói a flora protetora, permitindo supercrescimento de *Candida* — candidíase iatrogênica clássica.

→ Xerostomia Medicamentosa

Antidepressivos, anti-hipertensivos, anticolinérgicos e diuréticos reduzem o fluxo salivar, comprometendo a autolimpeza oral.

Formas Clínicas da Candidíase Oral

A candidíase oral se apresenta em quatro formas clínicas distintas, com características morfológicas, sintomatológicas e associações clínicas próprias. O reconhecimento de cada forma é fundamental para o diagnóstico correto e a escolha terapêutica adequada.



Pseudomembranosa

Forma mais comum. Placas brancas cremosas, facilmente removíveis com espátula, deixando base eritematosa e dolorosa. Locais típicos: mucosa jugal, palato, língua.



Eritematosa

Áreas avermelhadas, lisas, com sensação de queimação. Frequentemente associada ao uso de antibióticos e corticoides inalatórios. Pode ser subdiagnosticada por ausência de placas visíveis.



Hiperplásica

Placas brancas aderidas, não removíveis, de superfície rugosa. Importante diagnóstico diferencial com leucoplasia. Exige biópsia em casos persistentes para exclusão de displasia.



Queilite Angular

Fissuras eritematosas e crostosas nos cantos da boca. Etiologia frequentemente mista: candidíase + deficiência nutricional (ferro, B12, folato). Comum em idosos e portadores de próteses dentárias.

Candidíase Pseudomembranosa

A forma pseudomembranosa é a apresentação **mais frequente e mais reconhecida** da candidíase oral. Sua identificação é, na maioria das vezes, eminentemente clínica, dispensando exames complementares nos casos típicos.

Características Clínicas

- Placas brancas ou branco-amareladas, de aspecto cremoso ou coalescente, semelhantes a "leite coalhado"
- Removíveis com espátula ou gaze — este é o sinal clínico patognomônico
- Deixam base eritematosa, edemaciada e frequentemente sangrante após remoção
- Localização preferencial: mucosa jugal bilateral, palato mole, dorso de língua e orofaringe
- Pode causar disfagia leve quando compromete a orofaringe

Relevância para Gastroenterologia

A candidíase pseudomembranosa oral pode ser a porta de entrada para a candidíase esofágica — complicação grave em imunossuprimidos. Todo paciente com candidíase oral e disfagia deve ser investigado para acometimento esofágico, que exige tratamento sistêmico obrigatório.

Diagnóstico Diferencial

- Leucoplasia (não removível)
- Língua geográfica
- Estomatite aftosa

Candidíase Eritematosa

Apresentação Clínica

A candidíase eritematosa é a forma mais **silenciosa e subdiagnosticada**. Ao contrário da pseudomembranosa, não apresenta placas visíveis, o que dificulta o reconhecimento.

- Áreas avermelhadas, lisas, brilhantes e atenuadas na mucosa oral
- Sensação de queimação, ardência ou dor ao contato com alimentos ácidos ou condimentados
- Localização típica: palato duro e dorso de língua (aspecto de "língua careca" por atrofia das papilas)
- Pode ser a única manifestação de candidíase em pacientes com HIV em fase inicial

Contexto e Associações

Esta forma está classicamente associada a:

- **Antibioticoterapia de amplo espectro** — a chamada "candidíase do antibiótico"
- **Corticoides inalatórios** — especialmente em pacientes com asma ou DPOC que não realizam higiene bucal após a inalação
- **Próteses dentárias mal adaptadas** — "estomatite protética", forma específica de candidíase eritematosa

❏ Paciente com sensação de "boca em fogo" persistente após antibioticoterapia deve sempre levantar suspeita de candidíase eritematosa, mesmo na ausência de placas brancas visíveis.

Candidíase Hiperplásica e Queilite Angular

Candidíase Hiperplásica

Forma menos comum, porém a mais preocupante. Caracterizada por placas brancas espessas, aderidas à mucosa, que não se desprendem com espátula — diferencial fundamental da pseudomembranosa.

Locais típicos: comissura bucal, mucosa jugal anterior, língua. A superfície pode ser lisa, nodular ou verrucosa. A persistência por mais de 2 semanas após tratamento antifúngico empírico é indicação absoluta de **biópsia**, pois pode haver displasia ou carcinoma in situ subjacente.

Principal diagnóstico diferencial: leucoplasia oral, que pode coexistir ou ser confundida. Em casos de associação com tabagismo e álcool, o potencial de malignização é significativamente elevado.

Queilite Angular (Queilose)

Fissuras eritematosas, dolorosas, com ou sem crostas, localizadas nas comissuras labiais (cantos da boca). Possui **etiologia frequentemente multifatorial**:

- Infecção por *Candida* ± *S. aureus*
- Deficiência de ferro, riboflavina (B2), piridoxina (B6), B12
- Próteses dentárias com dimensão vertical reduzida
- Perda de peso significativa com alteração das comissuras

O tratamento deve ser dirigido à causa: antifúngico tópico + reposição nutricional quando indicada. Isoladamente, o antifúngico tem resposta parcial se houver deficiência nutricional concomitante.

Diagnóstico e Tratamento da Candidíase Oral

Abordagem Diagnóstica

O diagnóstico da candidíase oral é **predominantemente clínico** nas formas típicas. A anamnese deve explorar os fatores predisponentes já discutidos. O exame físico detalhado da cavidade oral — com boa iluminação e espátula — é imprescindível.

Quando solicitar exames complementares:

- **Exame direto com KOH 10%:** visualização de hifas e pseudo-hifas — rápido, barato e disponível
- **Cultura fúngica:** indica a espécie e permite teste de sensibilidade — útil em casos recorrentes ou refratários
- **Biópsia incisional:** obrigatória na forma hiperplásica persistente e em qualquer lesão com suspeita de malignidade
- **Investigação sistêmica:** glicemia, hemograma, sorologia HIV em casos recorrentes sem fator predisponente óbvio

Tratamento

Tópico (1ª linha)

Nistatina suspensão oral:

100.000 UI/mL, 4–6x/dia por 7–14 dias. **Miconazol gel oral:** alternativa de boa adesão.

Sistêmico (casos graves)

Fluconazol 150–200 mg/dia

por 7–14 dias. Indicado em imunossuprimidos, falha terapêutica ao tópico ou suspeita de acometimento esofágico.

Medidas Complementares

Correção do fator predisponente é essencial. Higiene bucal rigorosa, limpeza de próteses, ajuste de medicações quando possível.

Candidíase Recorrente — Sinal de Alerta

A candidíase oral recorrente — definida como três ou mais episódios por ano — não deve ser tratada de forma isolada. Ela representa um **marcador clínico importante** que exige investigação sistêmica aprofundada.



Doença Sistêmica Oculta

Diabetes mellitus não controlado ou não diagnosticado. HIV não rastreado. Neoplasias hematológicas (leucemia, linfoma). Síndrome de Sjögren com xerostomia grave.



Imunossupressão Contínua

Corticoterapia crônica (sistêmica ou inalatória). Imunobiológicos (anti-TNF, anti-integrinas). Quimioterapia em curso. Transplantados em uso de imunossupressores.



Falha Terapêutica

Resistência ao fluconazol (crescente em *C. glabrata* e *C. krusei*). Adesão inadequada ao tratamento. Persistência do fator predisponente não corrigido.

 **Conduta prática:** Todo paciente com candidíase recorrente sem fator predisponente evidente deve ser investigado com glicemia em jejum, hemograma completo, sorologia HIV e avaliação imunológica básica. Não repita o tratamento sem investigar a causa.

Infecções Virais da Cavidade Oral

As infecções virais orais constituem um grupo clinicamente relevante, especialmente em pacientes imunossuprimidos. Os três principais agentes no contexto da gastroenterologia são o Herpes Simples (HSV), o Vírus Epstein-Barr (EBV) e o Papilomavírus Humano (HPV), cada um com características clínicas e implicações terapêuticas distintas.

Herpes Simples (HSV-1/2)

Principal causa de vesículas e úlceras orais dolorosas. Latência nos gânglios sensoriais com reativação por estresse, imunossupressão ou trauma.

Epstein-Barr (EBV)

Associado à leucoplasia pilosa oral — marcador de imunossupressão. Também relacionado ao carcinoma nasofaríngeo e linfoma de Burkitt.

HPV

Múltiplos sorotipos. Lesões exofíticas orais (papiloma, condiloma). Sorotipos 16 e 18 associados ao carcinoma de orofaringe — impacto oncológico crescente.

Herpes Simples Oral — Manifestações e Conduta

Manifestações Clínicas

O HSV-1 é o principal agente do herpes labial e da gengivoestomatite herpética primária. A infecção primária, quando sintomática, é frequentemente mais grave:

- **Pródromo:** ardência, prurido, parestesia local nas 24–48h anteriores ao aparecimento das lesões
- **Vesículas agrupadas:** pequenas, translúcidas, sobre base eritematosa — no lábio, mucosa oral, gengiva ou palato
- **Ruptura e ulceração:** formação de úlceras rasas, dolorosas, com halo eritematoso, cobertas por fibrina
- **Resolução espontânea:** 7–14 dias na primoinfecção; 5–7 dias nas recorrências
- **Adenopatia regional** é comum na primoinfecção

Em imunossuprimidos, as lesões podem ser extensas, coalescentes, profundas e de resolução lenta — quadro que justifica tratamento sistêmico precoce.

Conduta Terapêutica

Primoinfecção em imunossuprimidos:

- Aciclovir 400 mg VO 5x/dia por 7–10 dias
- Valaciclovir 1g VO 2x/dia por 7–10 dias (melhor adesão)

Recorrências em imunocompetentes:

- Aciclovir tópico 5% — eficácia limitada, deve ser iniciado no pródromo
- Valaciclovir 2g VO 2x/dia por 1 dia — esquema episódico

Profilaxia em imunossuprimidos de alto risco:

- Aciclovir 400 mg VO 2x/dia — uso contínuo durante período de imunossupressão

Leucoplasia Pilosa Oral — Marcador de Imunossupressão

Características Clínicas e Patogênese

A leucoplasia pilosa oral (LPO) é causada pela replicação produtiva do Vírus Epstein-Barr (EBV) nas células epiteliais da língua, em contexto de imunossupressão celular. O EBV permanece latente nos linfócitos B de indivíduos infectados, mas quando a imunidade celular falha, passa a se replicar no epitélio oral.

Apresentação clínica:

- Placas brancas com estrias verticais paralelas, dando aspecto "corrugado" ou "piloso"
- Localização quase exclusiva nas **bordas laterais da língua** — bilateralmente
- Não removíveis com espátula — diferencial importante da candidíase pseudomembranosa
- Geralmente assintomáticas — descoberta frequentemente incidental
- Não tem potencial maligno, mas seu valor como **marcador de imunossupressão** é extraordinário

Implicações Clínicas

- ❑ A presença de leucoplasia pilosa oral deve sempre desencadear investigação para HIV, mesmo em pacientes sem fatores de risco aparentes. Historicamente, foi uma das primeiras lesões descritas na epidemia de AIDS.

Outras condições associadas:

- Transplantados em uso de imunossupressores
- Pacientes em quimioterapia
- Uso crônico de corticoides sistêmicos
- Doenças autoimunes com imunossupressão iatrogênica

O tratamento específico geralmente não é necessário, pois a LPO regride com melhora da imunossupressão.

Infecções Bacterianas e Relação com Gastroenterologia

Infecções Bacterianas Orais

As infecções bacterianas primárias da cavidade oral são menos frequentes que as fúngicas e virais, mas assumem relevância clínica em contextos específicos:

- **Imunossuprimidos graves** (neutropenia, HIV avançado): risco de periodontite necrosante e gengivite ulcerativa necrosante aguda (GUNA) — emergências infecciosas que podem evoluir para sepse
- **Infecções odontogênicas:** abscessos periapicais e periodontais que podem disseminar por continuidade ou via hematogênica, com risco de endocardite em pacientes cardiopatas
- **Actinomicose oral:** rara, mas pode mimetizar neoplasia — nódulos indurados com fístulas ("grãos de enxofre")

Relação com a Gastroenterologia

As infecções orais — fúngicas, virais e bacterianas — têm conexões diretas com a prática gastroenterológica que vão além do tratamento local:

- **Imunossupressão por doenças GI:** Doença de Crohn, retocolite ulcerativa e hepatopatias crônicas comprometem a imunidade e predisõem a infecções orais
- **Imunobiológicos:** Anti-TNF, vedolizumabe e ustekinumabe aumentam significativamente o risco de infecções oportunistas, incluindo as orais
- **Desnutrição:** Pacientes com má absorção intestinal (celíaca, Crohn, SIC) têm imunidade comprometida e mucosa vulnerável
- **Candidíase esofágica:** Extensão direta da oral em pacientes de risco — manifestação GI grave que exige tratamento sistêmico

Nutrição e Cavidade Oral — Visão Avançada

A integridade da mucosa oral é um **reflexo direto e sensível do estado nutricional** do paciente. As células do epitélio oral têm elevada taxa de renovação — com ciclo de 5 a 7 dias — o que as torna extremamente vulneráveis a deficiências de micronutrientes e macronutrientes.



Renovação Celular

Vitaminas do complexo B, ferro e proteínas são essenciais para a replicação e diferenciação do epitélio oral. Suas deficiências causam atrofia, ulceração e fragilidade mucosa.



Imunidade Local

Zinco, vitamina C e proteínas são pilares da imunidade inata local. A imunoglobulina A secretória (IgAs) — produzida nas glândulas salivares — depende de estado nutricional adequado para sua síntese.



Microbiota Oral

Deficiências nutricionais alteram a composição da microbiota oral, favorecendo espécies patogênicas sobre os comensais protetores — criando ciclo vicioso de inflamação e infecção.

Deficiência de Ferro — Manifestações Orais

Fisiopatologia e Manifestações

O ferro é cofator essencial para a síntese de DNA, respiração celular mitocondrial e manutenção da integridade epitelial. Sua deficiência impacta profundamente os tecidos com alta renovação celular — como a mucosa oral.

Manifestações orais características:

→ Glossite Atrófica

Atrofia das papilas filiformes e fungiformes, deixando a língua com superfície lisa, "careca", avermelhada ou pálida. Frequentemente dolorosa ao contato com alimentos quentes, ácidos ou condimentados. Marcador clássico de anemia ferropriva.

→ Palidez Mucosa

Palidez generalizada da mucosa oral — especialmente visível na mucosa jugal e palato mole. Sinal clínico de anemia que o gastroenterologista deve pesquisar ativamente.

→ Queilite Angular

Fissuras dolorosas nos cantos da boca, de etiologia mista com candidíase — já discutida anteriormente. A reposição de ferro é parte essencial do tratamento.

Contexto Gastroenterológico

- ❏ A deficiência de ferro é uma das mais prevalentes em doenças gastroenterológicas — doença celíaca, doença de Crohn ileocecal, gastrectomia e sangramento digestivo crônico são as principais causas. A glossite atrófica pode ser a primeira pista diagnóstica para investigar má absorção intestinal.

Síndrome de Plummer-Vinson (Patterson-Kelly): tríade clássica de disfagia alta por membrana esofágica + anemia ferropriva + glossite atrófica. Condição pré-maligna que exige dilatação endoscópica e reposição de ferro.

Investigação recomendada: ferritina sérica, ferro sérico, saturação de transferrina, hemograma completo e pesquisa da causa da deficiência.

Deficiência de Vitamina B12 e Ácido Fólico

Deficiência de Vitamina B12 (Cobalamina)

A deficiência de B12 causa **glossite de Hunter** — uma das manifestações clássicas da medicina interna. A língua torna-se lisa, brilhante, "envernizada", com atrofia completa das papilas e intensa sensação de queimação ou dormência.

Além da glossite, podem ocorrer:

- Ulcerações mucosas recorrentes inespecíficas
- Queilite angular
- Palidez mucosa associada à anemia megaloblástica
- Alterações neurológicas concomitantes: parestesias, ataxia, déficits cognitivos (subaguda combinada medular)

Causas gastroenterológicas frequentes: gastrectomia total ou parcial (perda de fator intrínseco), doença de Crohn ileal extensa, ressecção ileal, gastrite atrófica autoimune, uso prolongado de IBP e metformina.

Deficiência de Ácido Fólico (B9)

O folato é essencial para a síntese de DNA e proliferação celular rápida — como o epitélio oral. Sua deficiência causa manifestações semelhantes à deficiência de B12, porém sem as alterações neurológicas.

Manifestações orais:

- Ulcerações aftosas recorrentes — frequentemente múltiplas e dolorosas
- Glossite atrófica com queimação
- Inflamação mucosa difusa
- Anemia megaloblástica com palidez mucosa

Causas: doença celíaca (principal — má absorção no duodeno/jejuno proximal), uso de metotrexato e sulfassalazina (antagonistas do folato), alcoolismo crônico, dieta inadequada.

- ❏ Aftas recorrentes com glossite em paciente jovem do sexo feminino devem levantar suspeita de doença celíaca e deficiência de folato — investigar com anti-tTG IgA e dosagem de folato eritrocitário.

Deficiência de Zinco e Desnutrição Proteico-Calórica

Deficiência de Zinco

O zinco é um micronutriente com funções críticas para a saúde oral:

- **Alteração do paladar (hipogeusia/disgeusia):** o zinco é cofator da gustina, enzima da anidrase carbônica presente nas papilas gustativas. Sua deficiência causa perda ou distorção do paladar — sintoma frequentemente negligenciado, mas que impacta profundamente a ingestão alimentar e qualidade de vida
- **Cicatrização prejudicada:** essencial para síntese de colágeno e proliferação de queratinócitos — úlceras orais cicatrizam lentamente
- **Imunidade reduzida:** queda na função de células NK, linfócitos T e neutrófilos — aumenta suscetibilidade a infecções orais
- **Dermatite perioral:** eritema e descamação ao redor da boca em deficiências graves (acrodermatite enteropática)

Causas GI: doença de Crohn, SIC, diarreia crônica, acrodermatite enteropática (mutação no transportador de zinco SLC39A4).

Desnutrição Proteico-Calórica

A desnutrição proteico-calórica (DPC) representa o extremo do comprometimento nutricional, com impacto devastador sobre todos os compartimentos da saúde oral:

- **Atrofia da mucosa oral:** mucosa delgada, friável, com perda de sua função de barreira — porta de entrada para múltiplos patógenos
- **Aumento das infecções:** candidíase, herpes e infecções bacterianas tornam-se frequentes e de difícil controle na ausência de correção nutricional
- **Retardo de cicatrização:** úlceras orais e lesões traumáticas têm cicatrização extremamente lenta — perpetuando dor e dificuldade de alimentação
- **Glândulas salivares:** hipotrofia das parótidas (sinal de desnutrição grave), com redução do fluxo e qualidade salivar

Em pacientes gastroenterológicos desnutridos, a abordagem nutricional é parte inseparável do tratamento das lesões orais.

Doenças Gastroenterológicas e Manifestações Orais

As doenças gastroenterológicas podem manifestar-se na cavidade oral muito antes de seus sintomas digestivos se tornarem evidentes. O reconhecimento dessas lesões orais pode antecipar o diagnóstico gastroenterológico em meses ou anos, alterando significativamente o prognóstico do paciente.



Doença Celíaca

Aftas recorrentes e hipoplasia dentária como primeiras manifestações.



Doença de Crohn

Edema labial, úlceras lineares profundas e granulomas — "Crohn oral".



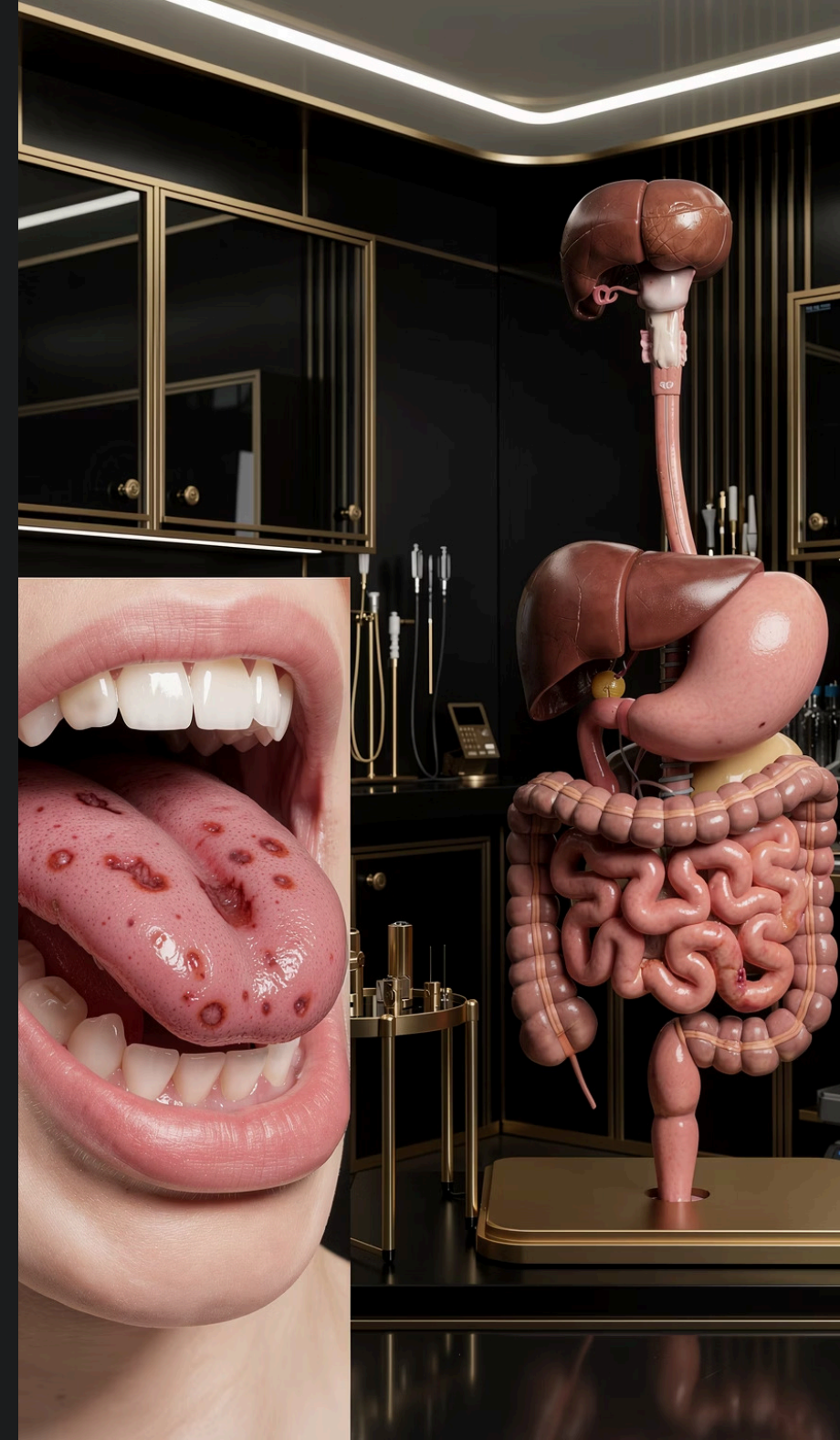
Retocolite Ulcerativa

Aftas e pioestomatite vegetante em paralelo à atividade intestinal.



Imunobiológicos

Risco aumentado de infecções oportunistas orais durante o tratamento.



Doença Celíaca e Cavidade Oral

Manifestações Oraís da Celíaca

A doença celíaca é reconhecida como uma condição multissistêmica, e suas manifestações orais podem **preceder o diagnóstico digestivo por anos**. O gastroenterologista deve investigar ativamente doença celíaca em pacientes com as seguintes lesões orais:

Aftas Recorrentes (Estomatite Aftosa Recorrente)

Ulcerações dolorosas, com halo eritematoso e pseudomembrana amarelada, de resolução espontânea em 1–3 semanas mas com recorrência frequente. Presentes em 3–61% dos celíacos (ampla variação em estudos). A dieta sem glúten reduz a frequência das recorrências em pacientes celíacos.

Hipoplasia do Esmalte Dentário

Defeitos quantitativos do esmalte (sulcos, fossas, opacidades) distribuídos **simetricamente** e **cronologicamente** nos dentes permanentes — padrão patognomônico quando presente. Resulta da absorção inadequada de cálcio e vitamina D durante a odontogênese. Presente em até 85% dos celíacos sintomáticos em alguns séries.

Deficiências Nutricionais Oraís

Glossite atrófica (ferro, B12, folato), queilite angular e palidez mucosa — reflexo da má absorção intestinal difusa.

Raciocínio Clínico Aplicado

- ❏ **Pérola clínica:** Criança com múltiplos defeitos no esmalte dos dentes permanentes, distribuídos simetricamente, deve ter doença celíaca investigada — independentemente de sintomas gastrointestinais.

Investigação recomendada:

- Anti-transglutaminase tecidual IgA (anti-tTG IgA) — triagem de escolha
- IgA total sérica (para excluir deficiência de IgA que falseia o resultado)
- Biópsia duodenal (mínimo 4 fragmentos) para confirmação histológica
- Hemograma, ferritina, B12, folato, vitamina D

A **dieta isenta de glúten** resulta em melhora das aftas recorrentes em 3–6 meses, podendo ser usada também como critério terapêutico de resposta.

Doença de Crohn — Manifestações Orais

A doença de Crohn é capaz de acometer qualquer segmento do trato gastrointestinal — e a boca, como porta de entrada do tubo digestivo, não é exceção. As manifestações orais do Crohn são denominadas coletivamente de "**Crohn oral**" ou **manifestação extraintestinal bucal**, podendo ocorrer antes, simultaneamente ou após o diagnóstico intestinal.

Manifestações Específicas (Patognomônicas)

- **Edema labial e facial:** macroquelia (lábios aumentados, borrachudos) por edema linfático granulomatoso — pode ser confundido com angioedema. Acomete especialmente o lábio inferior
- **Hiperplasia mucosa com aspecto "paralelepípedo":** mucosa oral com aparência nodular irregular, semelhante a calçamento — padrão histológico granulomatoso
- **Úlceras lineares profundas:** nas sulcos vestibulares (gengiva-mucosa), de aspecto linear, profundas, com bordas induradas — aspecto semelhante às úlceras intestinais longitudinais do Crohn
- **Granulomas na biópsia:** confirmação histológica — granulomas não caseosos idênticos aos da doença intestinal

Manifestações Inespecíficas (Extraintestinais)

- **Aftas recorrentes:** mais frequentes que na população geral, podendo ser o primeiro sintoma do Crohn
- **Pioestomatite vegetante:** lesões pustulosas que se fundem formando aspecto vegetante — manifestação extraintestinal clássica, compartilhada com a RCU
- **Queilite granulomatosa de Miescher:** forma monossintomática, localizada, do espectro do Crohn oral — edema labial recorrente por granulomas

❏ Na síndrome de Melkersson-Rosenthal (edema labial + paralisia facial + língua fissurada), o Crohn deve sempre ser considerado no diagnóstico diferencial.

Retocolite Ulcerativa e Uso de Imunobiológicos

Retocolite Ulcerativa (RCU)

As manifestações orais da RCU são **menos frequentes e menos específicas** que no Crohn, mas merecem atenção. Tendem a correlacionar-se com a atividade da doença intestinal.

Manifestações descritas:

- **Aftas recorrentes:** frequentes em períodos de atividade da doença — melhora com controle da inflamação intestinal
- **Pioestomatite vegetante:** lesões pustulosas vegetantes na mucosa oral e labial — marcador de atividade da RCU, pode ser confundida com infecções
- **Inflamação mucosa difusa inespecífica** durante surtos ativos

O tratamento das manifestações orais da RCU segue o controle da doença intestinal — corticoides tópicos orais para sintomas locais e adequação da terapia sistêmica para manifestações persistentes.

Pacientes em Uso de Imunobiológicos

Os imunobiológicos utilizados na DII — anti-TNF (infliximabe, adalimumabe), anti-integrinas (vedolizumabe) e anti-IL12/23 (ustekinumabe) — conferem **imunossupressão variável**, com diferentes perfis de risco infeccioso oral.

Riscos orais específicos:

- **Candidíase oral:** especialmente com anti-TNF, que reduz a imunidade celular e humoral local
- **Reativação do herpes simples:** triagem sorológica pré-terapia recomendada em anti-TNF
- **Leucoplasia pilosa oral:** marcador de imunossupressão excessiva — deve alertar para revisão da terapia
- **Lesões mucosas atípicas:** qualquer lesão oral persistente em paciente em uso de imunobiológico deve ser investigada com biópsia



Impacto do Álcool e Tabagismo na Cavidade Oral

Álcool — Efeitos na Mucosa Oral

O consumo crônico de álcool exerce múltiplos efeitos deletérios sobre a cavidade oral, com impacto crescente conforme a quantidade e duração do consumo:

- **Irritação química direta:** o etanol e seus metabólitos (acetaldeído) agredem diretamente o epitélio oral, causando inflamação crônica e alteração da permeabilidade mucosa
- **Deficiências nutricionais múltiplas:** o alcoolismo crônico está associado à deficiência de tiamina (B1), riboflavina (B2), folato, zinco e vitamina C — todas com manifestações orais específicas
- **Xerostomia:** o álcool tem efeito diurético e reduz o fluxo salivar, aumentando o risco de cáries e candidíase
- **Aumento de risco de câncer:** o acetaldeído é carcinogênico diretamente. O álcool é fator de risco independente para carcinoma espinocelular oral — risco multiplicado com tabagismo concomitante (efeito sinérgico)
- **Comprometimento da cicatrização:** por deficiências nutricionais e efeito imunossupressor do etanol

Tabagismo — Efeitos na Mucosa Oral

O tabagismo é um dos principais fatores de risco para lesões orais pré-malignas e malignas, além de alterar profundamente a resposta imune local:

- **Alteração da mucosa:** hiperkeratose (espessamento do epitélio), alteração da vascularização (mucosa pálida com vasos contraídos), pigmentação melanótica
- **Redução da imunidade local:** supressão da função de neutrófilos e macrófagos na mucosa — aumenta susceptibilidade a infecções periodontais e fúngicas
- **Leucoplasia tabágica:** lesão pré-maligna clássica — placa branca não removível, de bordas irregulares, com risco de transformação maligna de 1–17% ao longo de anos
- **Eritroplasia:** lesão vermelha com altíssimo potencial maligno (displasia grave em até 50% dos casos) — relação com tabaco e álcool
- **Melanose do fumante:** pigmentação escura gengival — benigna, mas indica exposição tabágica significativa

Integração Clínica — A Boca Como Janela do Corpo

A avaliação da cavidade oral deve ser parte rotineira da consulta gastroenterológica. Uma inspeção sistemática de 60 segundos pode revelar diagnósticos que mudariam o manejo clínico do paciente.

A integração clínica entre as alterações orais e as doenças sistêmicas representa uma habilidade semiológica de alto valor para o especialista em gastroenterologia. Não é necessário que o gastroenterologista realize procedimentos odontológicos, mas o **reconhecimento das principais lesões orais e sua correlação com doenças sistêmicas** é competência esperada do especialista.

Diagnóstico Precoce

Lesões orais como aftas recorrentes, glossite atrófica e hipoplasia do esmalte podem antecipar o diagnóstico de celiaca, DII e anemia em anos.

Monitoramento de Terapia

Candidíase oral em paciente em uso de imunobiológico pode sinalizar imunossupressão excessiva ou necessidade de revisão terapêutica.

Prevenção de Neoplasias

A identificação de leucoplasia, eritroplasia e lesões persistentes permite encaminhamento precoce para biópsia e intervenção antes da transformação maligna.

Raciocínio Clínico Estruturado Frente a uma Lesão Oral

Diante de qualquer lesão oral identificada no contexto da consulta gastroenterológica, o raciocínio clínico deve seguir uma abordagem sistemática que maximize a acurácia diagnóstica e minimize o risco de erro ou atraso no diagnóstico.



Passo 1 — Caracterização Morfológica

Descreva a lesão com precisão: tamanho, coloração (branca, vermelha, mista), bordas (regulares ou irregulares), superfície (lisa, rugosa, vegetante), base (sésil ou pediculada), consistência (mole ou endurecida à palpação), e — fundamentalmente — se é **removível ou não** com espátula.

Passos 2–4 — Contexto e Decisão

Avalie a **duração** (lesão há mais de 2–3 semanas sem regressão = sinal de alerta), **recorrência** (sugere fator sistêmico), **sintomas** (disfagia associada exige endoscopia). O contexto sistêmico — medicações, imunossupressão, estado nutricional, diagnósticos GI — deve orientar a hipótese. A biópsia deve ser indicada com baixo limiar em lesões atípicas ou persistentes.

Armadilhas Clínicas no Diagnóstico Oral

O domínio das armadilhas diagnósticas é o que separa o especialista do clínico geral. Conhecer os erros mais frequentes protege o paciente e eleva a qualidade do atendimento.

⚠ Tratar sem Investigar a Causa

Prescrever antifúngico para candidíase recorrente sem investigar o fator predisponente é o erro mais comum e perigoso. A causa pode ser diabetes não diagnosticado, HIV não rastreado ou neoplasia hematológica em curso. O tratamento sintomático repetido sem investigação atrasa diagnósticos graves.

⚠ Não Biopsiar Lesões Persistentes

Qualquer lesão branca (leucoplasia), vermelha (eritroplasia) ou mista que persista por mais de 2–3 semanas sem causa aparente deve ser biopsiada. Aguardar tratamento empírico por tempo excessivo pode atrasar o diagnóstico de carcinoma espinocelular em fase curável. A biópsia incisional é o padrão-ouro — nunca excisional em primeira abordagem.

⚠ Ignorar Sinais Sistêmicos Concomitantes

Tratar a lesão oral de forma isolada sem correlacionar com sintomas sistêmicos (perda de peso, diarreia, fadiga, disfagia) é perder a oportunidade diagnóstica. A cavidade oral é uma janela — o que se vê nela deve ser lido no contexto de todo o organismo.

⚠ Confundir Candidíase Hiperplásica com Leucoplasia

Ambas apresentam placas brancas não removíveis. A candidíase hiperplásica responde ao antifúngico em 2–4 semanas; a leucoplasia não. A persistência após tratamento antifúngico adequado é indicação absoluta de biópsia — a distinção só é possível histologicamente.

Quando Encaminhar — Critérios de Referência

Encaminhar ao Cirurgião Dentista / Estomatologista

Lesões Suspeitas

Qualquer lesão branca, vermelha ou ulcerada persistente por mais de 2 semanas, especialmente em tabagistas e etilistas. Lesões com bordas irregulares, induradas ou com ulceração central profunda.

Falha Terapêutica

Candidíase sem resposta após 2 semanas de antifúngico adequado. Aftas recorrentes sem resposta à correção nutricional. Lesões herpéticas extensas em imunossuprimidos.

Necessidade de Biópsia

O dentista/estomatologista realiza a biópsia incisional. Em centros especializados, a estomatologia é a especialidade de referência para lesões orais complexas.

Encaminhar ao Oncologista / Cabeça e Pescoço

Lesões com Biópsia Positiva

Displasia grave ou carcinoma in situ confirmado em biópsia. Todo carcinoma espinocelular oral deve ser encaminhado urgentemente para equipe de cirurgia de cabeça e pescoço.

Sinais de Alarme

Adenopatia cervical associada a lesão oral. Trismo (dificuldade de abertura bucal). Disfagia progressiva com lesão oral — investigar extensão orofaríngea e esofágica.

Seguimento Oncológico

Pacientes com história de carcinoma oral ou orofaríngeo necessitam de seguimento multidisciplinar — o gastroenterologista pode ser acionado para avaliação endoscópica de segunda neoplasia no TGI superior.

Integração Multidisciplinar

O manejo ideal das manifestações orais no contexto da gastroenterologia requer uma rede de especialistas integrada, onde cada profissional contribui com sua expertise específica para o benefício do paciente.



Gastroenterologia

Identificação das lesões orais na consulta. Correlação com doença digestiva. Investigação de doença celíaca, DII, hepatopatias. Manejo das deficiências nutricionais associadas. Revisão de imunobiológicos quando necessário.



Dermatologia

Doenças mucocutâneas com manifestação oral e cutânea simultânea: pênfigo vulgar, líquen plano, síndrome de Behçet. Avaliação de manifestações cutâneas associadas a doenças GI.



Odontologia / Estomatologia

Diagnóstico especializado das lesões orais. Realização de biópsias. Manejo odontológico do paciente com doença sistêmica. Prevenção e tratamento da doença periodontal em imunossuprimidos.

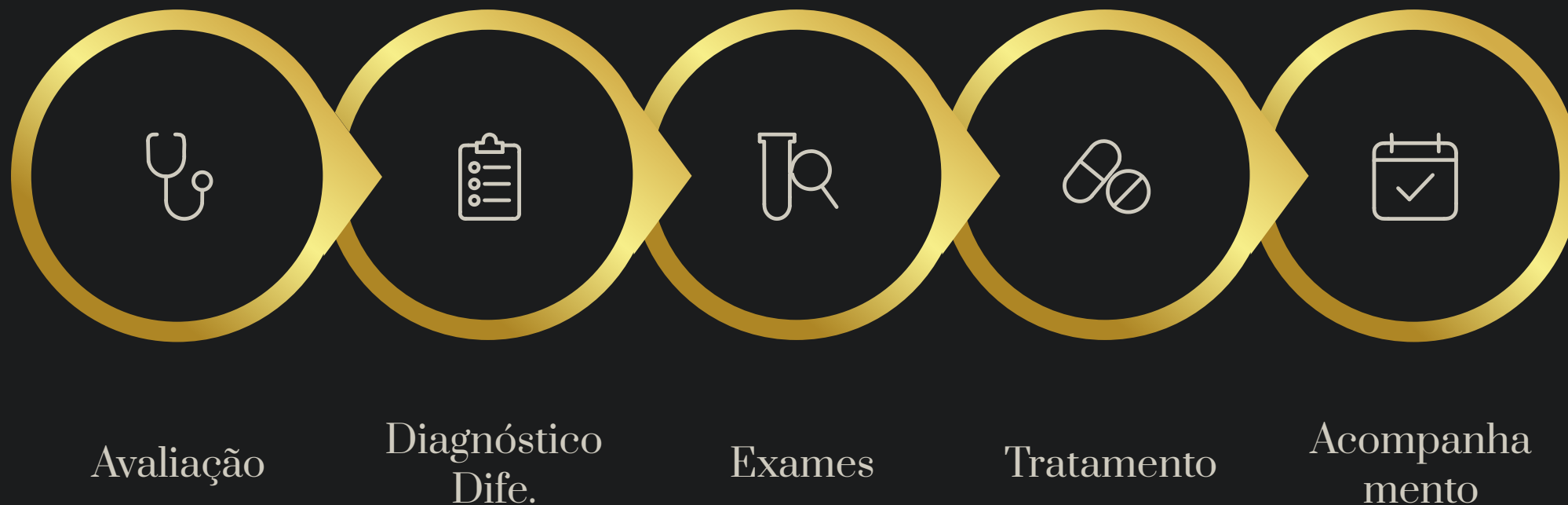


Oncologia

Avaliação e tratamento de displasias e carcinomas orais. Cirurgia de cabeça e pescoço. Radioterapia e quimioterapia — com consequentes complicações orais que exigem suporte multidisciplinar.

Fluxo de Atendimento — Do Sintoma ao Seguimento

A seguir, o fluxo estruturado para abordagem clínica de pacientes com lesões orais no contexto da gastroenterologia. Este protocolo garante sistematização, reduz erros e padroniza a tomada de decisão.



Este fluxo deve ser adaptado ao contexto clínico individual, com flexibilidade para acelerar as etapas quando há sinais de alarme (lesão suspeita de malignidade, imunossupressão grave, disfagia progressiva) ou desacelerar para investigação aprofundada em casos complexos.

Casos Clínicos — Raciocínio em Ação

Os casos clínicos a seguir apresentam cenários realistas do cotidiano da especialização em gastroenterologia. Para cada caso, o raciocínio diagnóstico e a conduta são apresentados de forma estruturada, com justificativa clínica baseada no conteúdo do módulo.

1

Caso 1

Aftas recorrentes em jovem mulher com anemia.

2

Caso 2

Candidíase oral recorrente em paciente sem fator predisponente aparente.

3

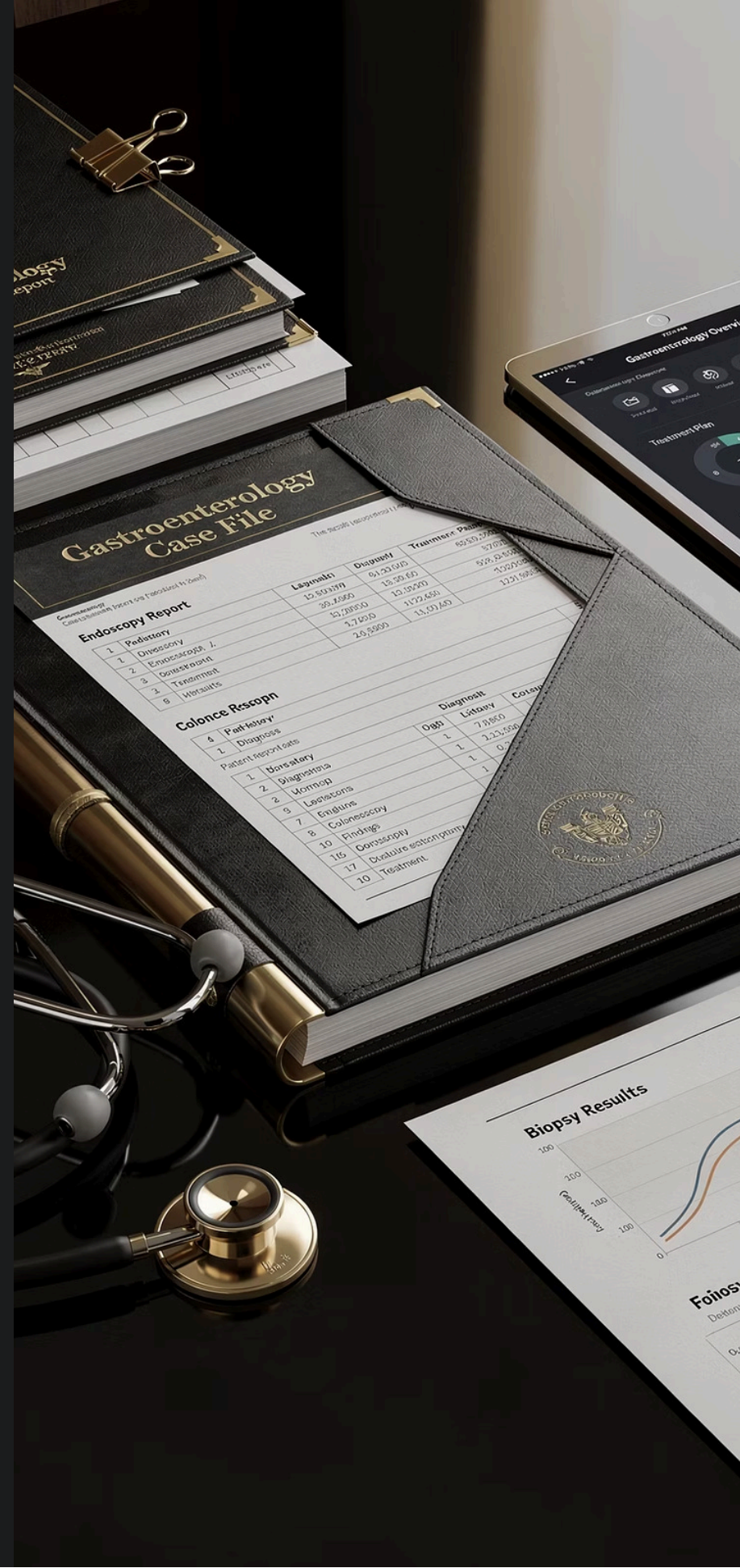
Caso 3

Leucoplasia persistente em tabagista após tratamento antifúngico.

4

Caso 4

Xerostomia importante em paciente com síndrome seca e artrite.



Caso Clínico 1 — Aftas Recorrentes

Apresentação

Paciente feminina, 28 anos, com história de 3 anos de aftas orais recorrentes — 3 a 5 episódios por ano, com lesões múltiplas, dolorosas, que dificultam alimentação. Refere cansaço, irregularidade intestinal (alternância diarreia/constipação) e perda de 4 kg no último ano sem dieta. Nega tabagismo e etilismo. Não usa medicamentos regularmente.

Exame físico: múltiplas úlceras rasas com halo eritematoso em mucosa jugal e palato mole. Língua com leve atrofia de papilas. Palidez conjuntival discreta.

Raciocínio Diagnóstico e Conduta

→ Investigar Deficiência Nutricional

Hemograma completo, ferro sérico, ferritina, vitamina B12, ácido fólico, zinco. A glossite atrófica e a palidez mucosa sugerem anemia por deficiência nutricional — provavelmente por má absorção.

→ Avaliar Doença Celíaca

Anti-tTG IgA + IgA total sérica. O perfil clínico — jovem, sexo feminino, aftas recorrentes, anemia, perda de peso e sintomas intestinais — é altamente sugestivo de celíaca. Biópsia duodenal se sorologia positiva.

→ Considerar DII

Se celíaca excluída, investigar doença de Crohn: calprotectina fecal, PCR, colonoscopia. Aftas recorrentes são manifestação extraintestinal frequente na DII.

❏ **Desfecho esperado:** Neste perfil, a probabilidade de doença celíaca é alta. Com diagnóstico confirmado e dieta sem glúten, as aftas tendem a regredir em 3–6 meses junto com a melhora nutricional.

Caso Clínico 2 — Candidíase Recorrente

Apresentação

Paciente masculino, 45 anos, com 4 episódios de candidíase oral pseudomembranosa no último ano, todos tratados com nistatina tópica com resposta inicial, mas com recorrência em 4–8 semanas. Refere polidipsia, poliúria e perda de peso de 8 kg nos últimos 6 meses. Não usa corticoides ou antibióticos de forma regular. Nega sintomas gastrointestinais. Atividade sexual de risco há 2 anos.

Exame físico: placas brancas removíveis em mucosa jugal e palato. Sem adenopatias palpáveis. IMC: 23 kg/m².

Raciocínio Diagnóstico e Conduta

→ Avaliar Diabetes Mellitus

Glicemia em jejum, HbA1c. Os sintomas clássicos de DM (polidipsia, poliúria, perda de peso) combinados com candidíase recorrente são fortemente sugestivos de DM tipo 2 descompensado ou DM tipo 1 de início tardio.

→ Investigar HIV

Sorologia anti-HIV 1 e 2. A atividade sexual de risco e a candidíase recorrente sem DM identificado obrigam a rastrear HIV. CD4⁺ e carga viral se positivo.

→ Revisar Medicações

Investigar uso de corticoides inalatórios (asma não referida?), antibióticos frequentes ou outros imunossupressores. Hemograma completo para excluir neutropenia ou neoplasia hematológica.

Caso Clínico 3 — Leucoplasia Persistente

Apresentação

Paciente masculino, 58 anos, tabagista pesado (40 anos/maço), etilista social, com placa branca em borda lateral de língua há 5 meses. Tratado empiricamente com fluconazol por 4 semanas pelo médico anterior — sem resposta. Nega dor ou disfagia. Exame: placa branca espessada, não removível, de superfície rugosa, 1,5 × 0,8 cm, bordas bem definidas. Sem adenopatia palpável.

Conduta

Biópsia Incisional — Obrigatória e Imediata

Neste cenário, a biópsia não deve ser postergada. A combinação de fatores de risco (tabagismo + álcool), duração de 5 meses, ausência de resposta ao antifúngico e localização de alto risco (borda de língua — área de alto potencial maligno) justificam biópsia sem nova tentativa terapêutica empírica.

- **Resultado possível:** hiperqueratose sem displasia (baixo risco), displasia leve/moderada (seguimento), displasia grave ou carcinoma in situ (tratamento cirúrgico), carcinoma espinocelular invasivo (encaminhamento urgente)
- **Encaminhamento:** estomatologista para biópsia; se positivo para displasia grave ou carcinoma, equipe de cirurgia de cabeça e pescoço

📌 **Regra de ouro:** Toda lesão oral branca não removível em tabagista com mais de 2 semanas de duração é leucoplasia até prova em contrário — e leucoplasia é lesão pré-maligna até histologia definir o contrário.

Caso Clínico 4 — Xerostomia Importante

Apresentação

Paciente feminina, 52 anos, com queixa principal de "boca seca" há 2 anos, com piora progressiva. Refere também "olhos secos", artralgia em mãos e fadiga crônica. Usa amitriptilina 25 mg/dia para depressão. Exame: mucosa oral seca, eritematosa, com fissuras na língua (língua fissurada) e cáries múltiplas recentes em paciente previamente sem histórico cariogênico relevante.

Raciocínio e Conduta

→ Investigar Síndrome de Sjögren

ANA, anti-Ro/SSA, anti-La/SSB, hemograma, PCR, VSH. Biópsia de glândula salivar menor (padrão-ouro para confirmação). A tríade xerostomia + ceratoconjuntivite seca + artralgia em mulher de meia-idade é altamente sugestiva de Sjögren primário.

→ Avaliar Componente Medicamentoso

A amitriptilina (efeito anticolinérgico) contribui para a xerostomia. Avaliar substituição por antidepressivo com menor efeito anticolinérgico (ISRS) em parceria com psiquiatra, se possível.

→ Relevância Gastroenterológica

Sjögren associa-se a esofagite por disfagia, constipação, cirrose biliar primária e pancreatite autoimune. A investigação GI é parte do follow-up multidisciplinar.

Casos Clínicos Avançados — Nível Especialista

Os casos clínicos avançados das páginas 161–179 do módulo exploram situações de maior complexidade diagnóstica e terapêutica, integrando múltiplas condições e exigindo domínio amplo dos temas abordados ao longo do curso. Cada cenário foi estruturado para desenvolver o raciocínio clínico do especialista em formação.



Candidíase Refratária

Paciente imunossuprimido com candidíase oral sem resposta ao fluconazol após 4 semanas. Aborda: resistência fúngica, troca para equinocandina, investigação de candidíase esofágica concomitante, revisão do regime imunossupressor.



Lesão Pré-Maligna com Progressão

Leucoplasia acompanhada por 6 meses com progressão para eritroleucoplasia. Aborda: indicadores de progressão, timing ideal para biópsia em série, critérios histológicos de displasia e decisão cirúrgica.



Doença Sistêmica com Manifestação Oral Inicial

Paciente sem diagnóstico prévio cuja lesão oral (edema labial granulomatoso) leva ao diagnóstico de Doença de Crohn. Aborda: sequência de investigação, papel da biópsia oral, início da terapia após diagnóstico estabelecido.



Imunossuprimido com Múltiplas Lesões

Transplantado renal com candidíase oral + leucoplasia pilosa + úlceras herpéticas simultâneas. Aborda: priorização terapêutica, interações medicamentosas, profilaxia secundária, seguimento ambulatorial.

Candidíase Refratária — Abordagem Avançada

Definição e Cenário

Candidíase oral é considerada refratária quando há **persistência ou recorrência precoce após fluconazol adequado** (dose, duração e adesão confirmadas). No contexto de imunossupressão grave — transplantados, pacientes em anti-TNF, HIV avançado — este cenário é progressivamente mais frequente.

Causas de refratariedade:

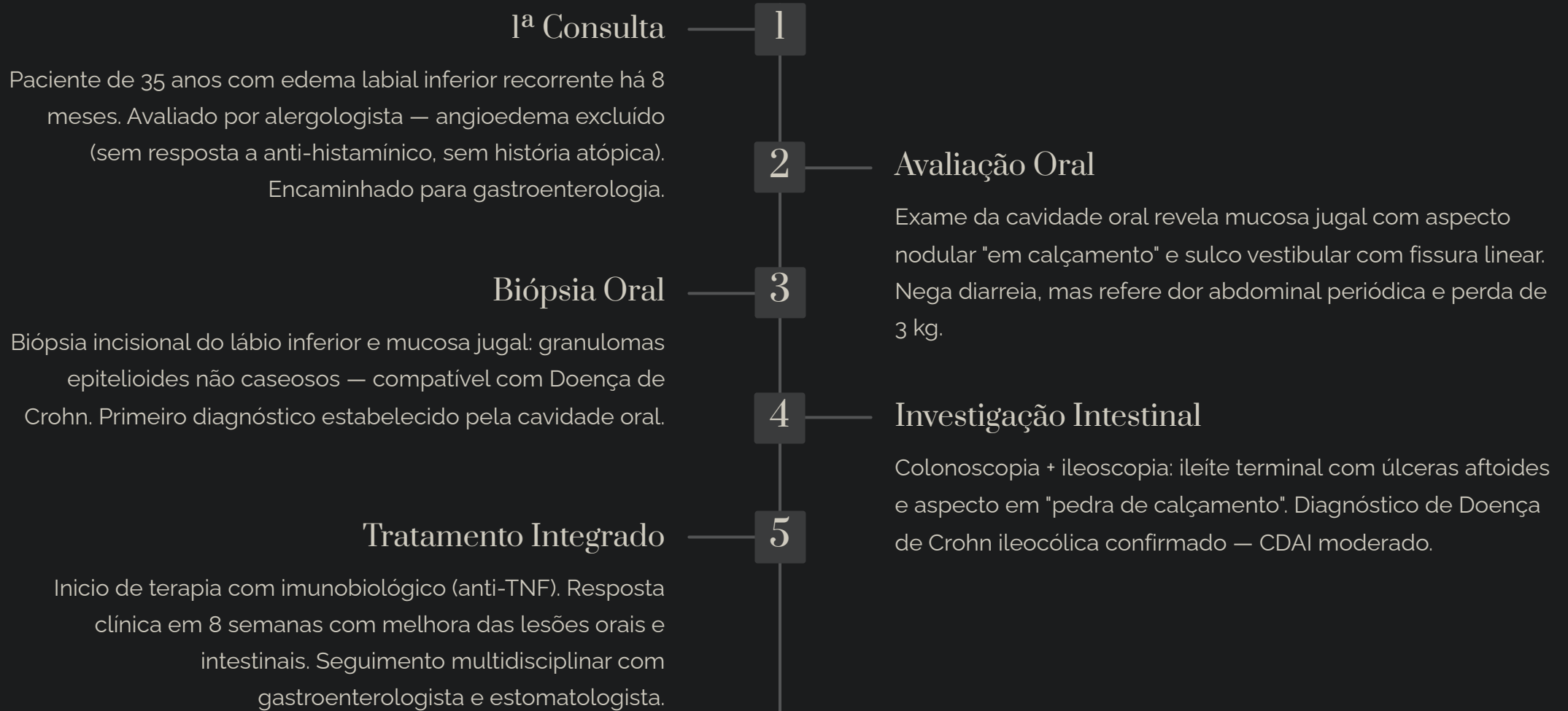
- Resistência intrínseca: *C. glabrata* (menor sensibilidade ao fluconazol) e *C. krusei* (resistência intrínseca ao fluconazol)
- Resistência adquirida: *C. albicans* resistente por exposição prévia e repetida a azóis
- Imunossupressão persistente não corrigida — "telhado de vidro" que perpetua a infecção
- Candidíase esofágica concomitante não diagnosticada — fonte de reinoculação oral

Conduta na Refratariedade

- **Cultura com antibiograma fúngico:** identificar a espécie e a sensibilidade — fundamental antes de trocar o antifúngico
- **Para *C. glabrata*:** voriconazol ou equinocandinas (caspofungina, micafungina) — atenção às interações com imunossupressores
- **Para *C. krusei*:** voriconazol — fluconazol contraindicado
- **Endoscopia digestiva alta:** investigar candidíase esofágica — sempre que houver disfagia ou candidíase oral refratária em imunossuprimidos
- **Revisão do regime imunossupressor:** avaliar com a equipe responsável pelo transplante ou pela DII a possibilidade de redução temporária da imunossupressão
- **Profilaxia secundária:** fluconazol 150 mg semanal em pacientes com HIV e CD4+ < 100 células/μL ou histórico de candidíase recorrente grave

Doença Sistêmica com Manifestação Oral Inicial

Um dos cenários mais desafiadores — e mais enriquecedores — da prática especializada: o paciente cuja **cavidade oral revela uma doença ainda não diagnosticada**. Este padrão ocorre com maior frequência do que se imagina.



Paciente Imunossuprimido com Múltiplas Lesões Orais

Cenário Clínico

Paciente masculino, 38 anos, transplantado renal há 3 anos, em uso de tacrolimus + micofenolato + prednisona 10 mg/dia. Comparece com queixa de múltiplas lesões orais dolorosas há 3 semanas:

- Placas brancas removíveis em palato e mucosa jugal (candidíase pseudomembranosa)
- Placas brancas estriadas em bordas laterais de língua, não removíveis (leucoplasia pilosa oral — EBV)
- Vesículas agrupadas em lábio inferior com ulcerações centrais (herpes simples recorrente)

Paciente relata disfagia leve para sólidos nos últimos 10 dias.

Hemograma recente: leucócitos $3.200/\text{mm}^3$, sem neutropenia grave.

Priorização e Conduta

1. Candidíase esofágica — prioridade urgente:

Disfagia em paciente com candidíase oral e imunossupressão = candidíase esofágica até prova em contrário. Iniciar fluconazol 400 mg/dia VO imediatamente, sem aguardar endoscopia (tratamento empírico). Endoscopia para confirmação em 48–72h se não houver resposta ou se houver disfagia grave.

2. Herpes simples:

Aciclovir 400 mg VO 5x/dia por 7–10 dias. Em transplantados, sempre tratamento sistêmico — nunca apenas tópico.

3. Leucoplasia pilosa oral:

Marcador de imunossupressão excessiva. Não requer tratamento específico. Avaliar com nefrologista a possibilidade de ajuste do regime imunossupressor.

4. Profilaxia a longo prazo:

Discutir introdução de aciclovir 400 mg 2x/dia e fluconazol 150 mg semanalmente como profilaxia secundária.

Deficiências Nutricionais — Síntese Visual

A tabela a seguir sumariza as principais deficiências nutricionais com manifestações orais relevantes no contexto da gastroenterologia, permitindo correlação rápida entre a lesão oral, o nutriente deficiente e a causa gastroenterológica mais provável.

Manifestação Oral	Nutriente Deficiente	Exame Diagnóstico	Causa GI Frequente
Glossite atrófica + palidez mucosa	Ferro	Ferritina, Fe sérico, hemograma	Celiaca, Crohn, sangramento GI, gastrectomia
Língua lisa e dolorosa (Hunter)	Vitamina B12	B12 sérica, hemograma	Gastrectomia, Crohn ileal, gastrite atrófica, IBP crônico
Aftas recorrentes + glossite	Ácido fólico	Folato eritrocitário, homocisteína	Celiaca, metotrexato, sulfassalazina, alcoolismo
Queilite angular	Ferro, B2, B6, B12	Painel nutricional completo	Múltiplas (má absorção, desnutrição)
Disgeusia / hipogeusia	Zinco	Zinco sérico	Crohn, SIC, diarreia crônica
Atrofia mucosa difusa	Proteínas + múltiplos	Albumina, pré-albumina, painel nutricional	Desnutrição grave, SIC, pancreatite crônica

Candidíase Oral vs. Leucoplasia — Diagnóstico Diferencial Crítico

A distinção entre candidíase hiperplásica e leucoplasia é um dos **diagnósticos diferenciais mais importantes** da estomatologia, com implicações diretas no manejo clínico e no prognóstico oncológico.



📌 **Regra prática:** Trate toda placa branca não removível com antifúngico por 2-4 semanas. Se houver resposta completa → candidíase hiperplásica. Se persistir → biópsia obrigatória para excluir displasia ou carcinoma. Nunca postergue indefinidamente a biópsia de uma lesão que não responde.

Manifestações Orais nas Doenças Inflamatórias Intestinais

DOENÇA DE CROHN



RETOCOLITE ULCERATIVA



DOENÇA CELÍACA



O Espectro das Lesões Orais Brancas

As lesões brancas da cavidade oral constituem um dos grupos mais heterogêneos e clinicamente relevantes da estomatologia. Sua importância reside no amplo espectro de diagnósticos — de condições benignas a lesões francamente malignas — que podem apresentar aparência similar.



Xerostomia — Abordagem Clínica Completa

Definição e Impacto

Xerostomia é a **sensação subjetiva de boca seca**, enquanto hipossalivação é a redução objetiva do fluxo salivar ($< 0,1$ mL/min em repouso ou $< 0,7$ mL/min estimulado). Ambas podem coexistir ou ocorrer isoladamente.

A saliva é muito mais que simples lubrificante: contém IgA secretória, enzimas antimicrobianas (lisozima, lactoferrina, peroxidases), fatores de crescimento e tampões que mantêm o pH oral. Sua ausência tem consequências sistêmicas:

- Cáries rampantes — especialmente cervicais e em superfícies lisas
- Doença periodontal acelerada
- Candidíase oral recorrente
- Disfagia e dificuldade de deglutição — impacto na nutrição
- Disgeusia — perda do prazer alimentar

Causas e Investigação

Síndrome de Sjögren

Principal causa sistêmica.
Anti-Ro/La, biópsia de glândula salivar menor.
Associação com cirrose biliar primária e pancreatite autoimune (relevância GI).

Medicamentosa

Anticolinérgicos, antidepressivos tricíclicos, ISRS, anti-hipertensivos (diuréticos, betabloqueadores), anti-histamínicos. Revisão cuidadosa da farmacoterapia.

Radioterapia Cervical

Dano irreversível às glândulas salivares maiores — xerostomia permanente e grave. Relevante em pacientes com histórico de câncer de cabeça e pescoço.

Desidratação / Doença Sistêmica

DM descompensado, IRC, doenças GI com perdas hídricas significativas. Tratar a causa de base.

HPV Oral e Câncer de Orofaringe

O Papilomavírus Humano (HPV) emergiu como **fator etiológico crescente e preocupante** no carcinoma de orofaringe — especialmente base de língua e amígdala palatina. Este padrão epidemiológico representa uma mudança no perfil do câncer oral, anteriormente dominado pelo tabaco e álcool.

HPV e Lesões Oraais

- **Papiloma oral escamoso:** lesão exofítica branca, pediculada, com projeções em "couve-flor" — sorotipo HPV 6 e 11 (baixo risco). Tratamento cirúrgico local.
- **Condiloma acuminado oral:** transmissão sexual. Múltiplas lesões. Investigar DSTs associadas.
- **Verruga vulgar oral:** HPV 2 e 4 — autoinoculação de verrugas cutâneas.
- **Lesões de alto risco:** HPV 16 e 18 — relação forte com carcinoma de orofaringe. Frequentemente sem lesão visível macroscópica precursora.

Epidemiologia e Rastreamento

O carcinoma de orofaringe HPV-positivo tem perfil diferente do tabaco/álcool: pacientes mais jovens (40–60 anos), sexo masculino predominante, histórico de múltiplos parceiros sexuais, melhor prognóstico com tratamento.

- ❑ Não existe rastreamento oral específico para HPV recomendado para a população geral no Brasil. A vacinação HPV quadrivalente/bivalente, já incorporada ao PNI para adolescentes, protege contra os sorotipos 16 e 18 — prevenção primária do carcinoma de orofaringe em longo prazo.

Mucosite Oral — Complicação da Químio e Radioterapia

Embora não seja o foco central deste módulo, a mucosite oral merece menção pela sua relevância no manejo de pacientes gastroenterológicos com doenças oncológicas e por sua relação direta com o estado nutricional e a continuidade do tratamento oncológico.

Fisiopatologia e Gradação

A mucosite oral é resultado da **citotoxicidade direta sobre o epitélio oral** por agentes quimioterápicos (metotrexato, 5-FU, antraciclinas) ou radiação na região de cabeça e pescoço. Inicia-se com atrofia epitelial, progride para ulceração com pseudomembrana e pode chegar a ulcerações confluentes extremamente dolorosas.

Gradação WHO (0 a 4):

- Grau 0: sem alterações
- Grau 1: eritema, queimação sem úlceras
- Grau 2: eritema + úlceras, paciente consegue alimentar-se
- Grau 3: úlceras extensas, apenas líquidos tolerados
- Grau 4: alimentação oral impossível — suporte nutricional enteral ou parenteral necessário

Manejo e Impacto Nutricional

Prevenção e tratamento:

- Higiene oral rigorosa com clorexidina 0,12% (embora evidências controversas)
- Crioterapia oral durante infusão de 5-FU (evidência moderada)
- Laser de baixa potência (LLLT) — redução de grau e duração (evidência crescente)
- Controle da dor: analgesia escalonada, anestésicos tópicos (lidocaína viscosa)
- Antifúngicos profiláticos em graus 3–4 (risco de candidíase superposta)

Impacto nutricional: mucosite grau 3–4 é uma das principais causas de interrupção do tratamento oncológico. A terapia nutricional enteral (SNE ou gastrostomia) pode ser necessária para manutenção do estado nutricional e continuidade da quimio/radioterapia.

Lesões Oraís como Marcadores de Atividade de Doença

Uma perspectiva clínica particularmente útil: as lesões orais não são apenas manifestações de doenças — em muitos casos, funcionam como **barômetros da atividade** de doenças sistêmicas. Sua evolução paralela pode orientar o manejo.



Aftas e Atividade da DII

Em pacientes com Doença de Crohn ou RCU, a recorrência de aftas frequentemente acompanha ou precede surtos de atividade intestinal em dias a semanas. Paciente com piora das aftas deve motivar avaliação de atividade da DII com calprotectina fecal, PCR e eventual colonoscopia.



Glossite e Deficiência Nutricional

O surgimento ou piora de glossite atrófica em paciente celiaco em dieta sem glúten pode indicar transgressão alimentar inadvertida, deficiência nutricional residual ou síndrome de refratariedade à dieta. Deve motivar reavaliação dietética e laboratorial.



Leucoplasia Pilosa e Imunossupressão

O surgimento de leucoplasia pilosa em paciente transplantado ou em uso de imunobiológico pode indicar imunossupressão excessiva. Funciona como sinal de alerta para revisão das doses e rastreamento de outras infecções oportunistas (CMV, Pneumocystis).

Pioestomatite Vegetante — Manifestação Extraintestinal Rara e Específica

Características e Diagnóstico

A pioestomatite vegetante é uma manifestação extraintestinal rara e altamente específica das doenças inflamatórias intestinais — especialmente da RCU, mas também descrita no Crohn. Caracteriza-se por:

- Múltiplas **pústulas superficiais** que se rompem e fundem, formando erosões com aspecto **vegetante ou "em trilhos de cobra"**
- Localização: lábios, mucosa jugal, sulcos vestibulares, palato
- Intensamente dolorosa — interfere com alimentação e hidratação
- Histologia: infiltrado eosinofílico intraepitelial com microabscessos — padrão diagnóstico

A pioestomatite vegetante **correlaciona-se com a atividade da DII** — tende a melhorar com o controle da inflamação intestinal.

Diagnóstico Diferencial e Conduta

Diagnósticos diferenciais importantes:

- Pênfigo vulgar (autoanticorpos anti-desmogleína)
- Penfigoide mucoso
- Dermatose IgA linear
- Infecção bacteriana mista

A **biópsia com imunofluorescência direta** é essencial para o diagnóstico diferencial — especialmente para excluir doenças bolhosas autoimunes.

Tratamento:

- Corticoide tópico oral (triancinolona em orabase) para sintomas locais
- Controle da DII subjacente — otimização da terapia sistêmica
- Em casos graves, corticoide sistêmico ou dapsona pode ser necessário

Síndrome de Behçet — Diagnóstico Diferencial das Aftas Graves

A Síndrome de Behçet é uma vasculite sistêmica de causa desconhecida que deve estar sempre no diagnóstico diferencial de aftas graves e recorrentes — especialmente quando associadas a outras manifestações sistêmicas. Sua relevância para o gastroenterologista vai além das lesões orais.

Critérios Diagnósticos (ICBD 2014)

O diagnóstico é clínico, baseado em critérios de pontuação:

- **Aftas orais recorrentes:** 2 pontos (obrigatório na maioria dos critérios)
- **Úlceras genitais:** 2 pontos
- **Lesões oculares** (uveíte, vasculite retiniana): 2 pontos
- **Lesões cutâneas** (eritema nodoso, pseudo-foliculite, pseudoacne): 1 ponto
- **Manifestações neurológicas:** 1 ponto
- **Manifestações vasculares** (trombose venosa, aneurisma): 1 ponto

Score ≥ 4 = diagnóstico de Behçet.

Manifestações Gastrointestinais

O trato GI é acometido em 10–50% dos pacientes com Behçet (maior prevalência em asiáticos), com um padrão clínico e endoscópico que pode mimetizar a Doença de Crohn:

- Úlceras ileocecais — úlceras profundas, solitárias ou escassas, de bordas bem definidas ("ovais ou redondas")
- Dor abdominal periumbilical ou em fossa ilíaca direita
- Hemorragia digestiva — risco de perfuração
- Fístulas e estenoses (menos frequentes que no Crohn)

❏ Diferencial Behçet vs. Crohn: no Behçet, as úlceras são redondas e bem delimitadas, localizadas preferencialmente na área ileocecal, sem o aspecto "em pedra de calçamento" típico do Crohn. A biópsia mostra vasculite, não granulomas.

Estomatite Aftosa Recorrente — Classificação e Manejo

A estomatite aftosa recorrente (EAR) é a lesão ulcerosa oral mais prevalente na população geral. O gastroenterologista deve conhecer sua classificação para distinguir formas primárias de manifestações de doenças sistêmicas tratáveis.

Aftosa Minor (Mikulicz)

Forma mais comum (80% dos casos).
Úlceras < 1 cm, rasas, com halo eritematoso e pseudomembrana amarelada. Localização: mucosa não ceratinizada (jugal, labial, língua ventral). Resolução espontânea em 7–14 dias sem cicatriz. Frequência: 3–6 episódios/ano.

Aftosa Major (Sutton)

Úlceras > 1 cm, profundas, com duração de 4–6 semanas e cicatrização com formação de fibrose. Extremamente dolorosas, interferem com alimentação. Associação mais forte com DII, HIV e imunossupressão. Tratamento: corticoide sistêmico em casos graves.

Aftose Herpetiforme

Múltiplas úlceras pequenas (1–3 mm), em grupos de 10–100, que coalescem em grandes úlceras irregulares. Apesar do nome, não tem relação com herpes simples. Associação com anemia por deficiência de ferro e celíaca.

📌 **Quando investigar sistematicamente:** EAR com início após os 25 anos (incomum na primária), aftas major ou herpetiformes, associação com sintomas GI/sistêmicos, déficit nutricional laboratorial, ausência de remissão com tratamento tópico.

Álcool, Tabaco e Cancerização de Campo

O Conceito de Cancerização de Campo

O conceito de "**cancerização de campo**" (field cancerization) é fundamental para entender o risco oncológico oral em tabagistas e etilistas. Proposto por Slaughter em 1953, descreve o fenômeno pelo qual a exposição crônica a carcinógenos (tabaco + álcool) provoca alterações genéticas difusas no epitélio da mucosa oral — criando um **campo de mutações pré-malignas** mesmo nas áreas macroscopicamente normais.

Implicações clínicas práticas:

- O risco de uma segunda neoplasia oral primária em paciente tratado de carcinoma oral é de 10–40% em 5 anos
- Lesões sincrônicas (múltiplas neoplasias simultâneas) são mais frequentes em tabagistas pesados
- A excisão de uma leucoplasia não elimina o risco de desenvolvimento de neoplasia em área adjacente
- A cessação tabágica é a intervenção com maior impacto na redução do risco — mas o risco permanece elevado por anos após a cessação

Risco Relativo e Sinergismo

O carcinoma espinocelular oral tem fatores de risco bem estabelecidos:

6x

Tabagismo

Risco relativo isolado para
carcinoma oral

6x

Etilismo

Risco relativo isolado para
carcinoma oral

30x

Ambos

Risco relativo com tabaco +
álcool combinados (efeito
sinérgico multiplicativo)

Avaliação Oral Sistemática na Consulta — Protocolo Prático

A inspeção oral durante a consulta gastroenterológica não precisa ser demorada — mas deve ser **sistemática e intencional**. Um protocolo de 2–3 minutos com iluminação adequada e espátula é suficiente para identificar as lesões mais relevantes.



O Que Registrar no Prontuário

- Localização exata da lesão (usar termos anatômicos precisos)
- Tamanho (em centímetros)
- Coloração e aspectos da superfície
- Se removível ou não com espátula
- Duração e evolução (crescimento, estabilidade, regressão)
- Sintomas associados (dor, ardência, disfagia)

Quando Fotografar

A documentação fotográfica de lesões orais é uma prática crescente e altamente recomendada em centros especializados. Permite o acompanhamento longitudinal, discussão em equipe multidisciplinar e referência para segunda opinião sem necessidade de novo exame. Registre sempre com o consentimento do paciente e com referência de escala (espátula ou régua milimetrada).

Interações Medicamentosas Relevantes no Tratamento Oral

O gastroenterologista frequentemente prescreve ou gerencia esquemas terapêuticos complexos. O conhecimento das principais interações medicamentosas envolvendo antifúngicos e antivirais orais é essencial para a segurança do paciente.

Medicamento Oral	Interage com	Consequência	Conduta
Fluconazol	Tacrolimus, Ciclosporina	Aumento dos níveis de imunossuppressores — toxicidade renal e neurológica	Monitorar níveis séricos, reduzir dose do imunossupressor
Fluconazol	Varfarina	Potencialização do anticoagulante — risco de sangramento	Monitorar INR diariamente na fase inicial
Fluconazol	IBP (omeprazol)	Aumento dos níveis de IBP — não clinicamente relevante em doses habituais	Sem ajuste necessário em doses habituais
Aciclovir	Nefrotóxicos (AINE, aminoglicosídeos)	Risco aumentado de nefrotoxicidade do aciclovir	Hidratação adequada, monitorar função renal
Voriconazol	Sirolimus / Everolimus	Aumento dramático dos níveis de inibidores de mTOR	Contraindicação relativa — evitar combinação ou monitorização intensiva

Língua — Atlas de Manifestações Clínicas

A língua é o órgão oral que mais frequentemente exhibe manifestações de doenças sistêmicas. Seu exame detalhado é de alto rendimento diagnóstico.



Glossite Atrófica / Língua Geográfica

Atrofia das papilas filiformes com áreas lisas e avermelhadas. Na glossite atrófica: deficiência de ferro, B12, folato — investigar causa sistêmica. Na língua geográfica (glossite migratória benigna): benigna, sem necessidade de investigação.



Leucoplasia Pilosa Oral

Placas brancas estriadas verticalmente nas bordas laterais da língua — EBV em contexto de imunossupressão. Não removível. Marcador de imunossupressão significativa.



Língua Fissurada (Plicata)

Fissuras profundas na superfície dorsal. Geralmente benigna e familiar. Associação com síndrome de Melkersson-Rosenthal e Doença de Crohn (investigar se associada a edema labial).



Língua Pilosa Negra

Elongação e coloração escura das papilas filiformes por supercrescimento bacteriano/fúngico. Associada a antibioticoterapia, tabagismo, xerostomia. Benigna — resolve com higiene e remoção da causa.

Microbioma Oral e Saúde Sistêmica

A compreensão do microbioma oral como ecossistema dinâmico com conexões sistêmicas representa uma das fronteiras mais instigantes da medicina atual. O microbioma oral contém mais de 700 espécies identificadas e tem interações documentadas com múltiplos sistemas orgânicos.

Conexões com o Trato Gastrointestinal

- **Eixo oral-intestinal:** bactérias orais — especialmente *Fusobacterium nucleatum* e *Porphyromonas gingivalis* — são detectadas em maior abundância na microbiota intestinal de pacientes com doença inflamatória intestinal e câncer colorretal
- ***Fusobacterium nucleatum* e câncer colorretal:** evidências crescentes de que esta bactéria periodontal pode ter papel promotor na carcinogênese colorretal — mecanismos incluem invasão da mucosa intestinal, ativação de oncogenes e evasão imune
- ***Helicobacter pylori*:** a colonização oral por *H. pylori* pode ser fonte de reinoculação gástrica após erradicação — implicações para o tratamento de casos refratários
- **Translocação bacteriana:** em pacientes com barreira intestinal comprometida (cirrose, DII), bactérias orais podem translocar e contribuir para infecções sistêmicas

Implicações Clínicas Emergentes

- **Doença periodontal e DII:** estudos epidemiológicos sugerem maior prevalência e gravidade de doença periodontal em pacientes com DII — relação bidirecional com inflamação sistêmica
- **Microbioma oral e cirrose:** disbiose oral documentada em pacientes cirróticos com encefalopatia hepática — potencial alvo terapêutico
- **Perspectivas futuras:** modulação do microbioma oral como estratégia terapêutica adjuvante — probióticos orais, fago-terapia, higiene oral direcionada ao perfil microbiano

📌 O gastroenterologista do século XXI precisará integrar conhecimentos de microbioma oral às suas decisões clínicas — um campo em rápida expansão com implicações terapêuticas concretas.

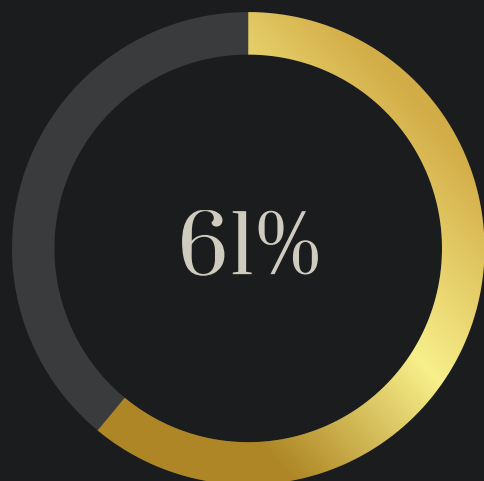
Lesões Pré-Malignas — Monitoramento e Seguimento

O seguimento estruturado de lesões pré-malignas orais é uma competência clínica de alta responsabilidade. A taxa de transformação maligna varia amplamente e depende de fatores histológicos, clínicos e comportamentais.



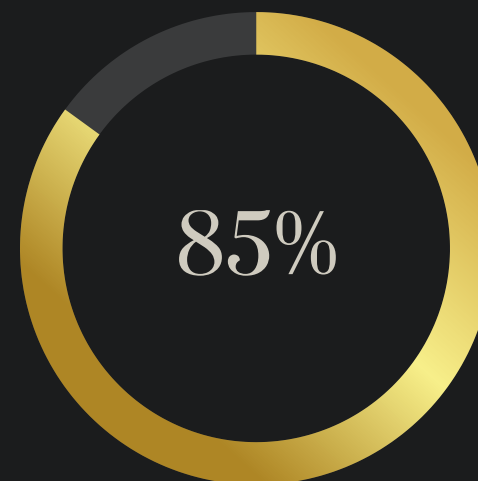
O seguimento mínimo recomendado para leucoplasias sem displasia é semestral no primeiro ano e anual após estabilidade confirmada. Qualquer mudança morfológica — crescimento, aparecimento de área eritematosa, ulceração — deve desencadear nova biópsia imediata.

Resumo — Deficiências Nutricionais e Manifestações Orais



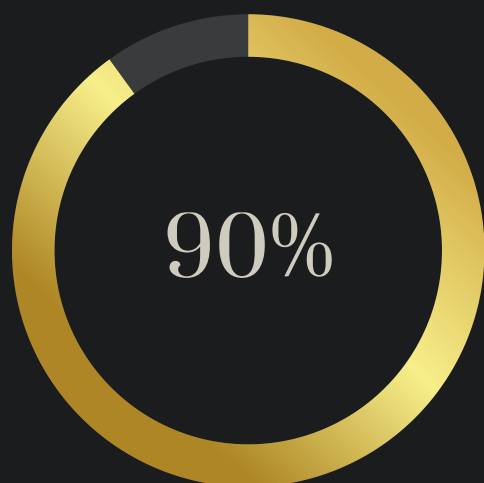
Celíaca com Aftas

Prevalência de aftas recorrentes em pacientes celíacos em algumas séries — dado que reforça a investigação rotineira



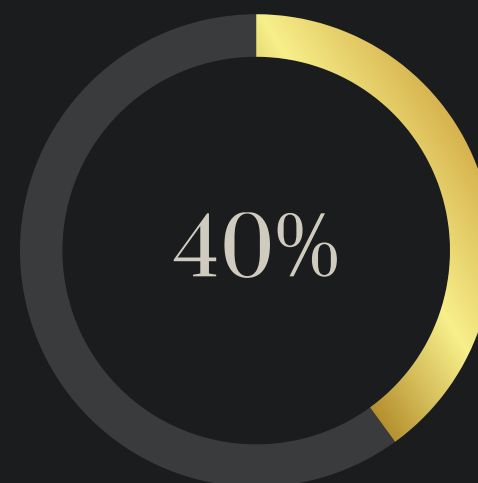
Hipoplasia Dentária

Prevalência de hipoplasia do esmalte nos dentes permanentes em celíacos sintomáticos com diagnóstico tardio



Candidíase no HIV

Prevalência de candidíase oral em pacientes com AIDS sem tratamento antirretroviral — marcador de imunossupressão grave



2ª Neoplasia Oral

Risco de segunda neoplasia oral primária em 5 anos em paciente já tratado de carcinoma oral — conceito de cancerização de campo

Integrando o Conhecimento — Mapa Conceptual



Síntese Final — Nível Especialista

As manifestações orais representam uma interface crítica entre gastroenterologia, nutrição e imunologia. O domínio desse tema permite diagnóstico precoce, prevenção de neoplasias e abordagem clínica verdadeiramente integrada.

Diagnóstico Precoce

A cavidade oral pode revelar doenças sistêmicas antes dos sintomas digestivos. Celíaca, DII, HIV, anemia e diabetes podem se manifestar primeiro na boca.

Prevenção de Neoplasias

Identificação de leucoplasias, eritroplasias e lesões persistentes permite intervenção precoce. Orientação sobre cessação tabágica e alcoólica reduz drasticamente o risco oncológico.

Abordagem Integrada

A colaboração com odontologia, dermatologia e oncologia é essencial. O gastroenterologista como coordenador do cuidado integrado garante melhor desfecho ao paciente complexo.

Melhor Desfecho

Cada diagnóstico oral que antecipa uma doença sistêmica, cada lesão pré-maligna interceptada, cada deficiência nutricional corrigida representa um desfecho clínico melhor e uma vida transformada.

 **Competência esperada ao final deste módulo:** realizar inspeção oral sistematizada, reconhecer as principais lesões orais com relevância gastroenterológica, correlacionar as manifestações com doenças sistêmicas, indicar investigação apropriada e encaminhar com critério — integrando a cavidade oral à sua prática gastroenterológica cotidiana.